



表 44 ECMO 患者转运流程：院内转运（2）

二、院内转运		
2.4 转运中监测		
参数	频率	记录
MAP / HR / SpO ₂	持续	
ECMO 流量 / RPM	持续	
TMP	每 10-15 min	
管路颜色	持续	
患者意识/瞳孔	每 10-15 min（镇静下观察瞳孔）	
氧瓶压力	每 15 min	
2.5 转运中紧急处理预案		
紧急情况	处理	关键动作
ECMO 泵停转	立即启动手摇泵	管道钳→换手摇→1500 RPM
管路脱出/破裂	立即钳闭断裂处两侧→停泵→压迫出血点→呼救	管道钳就在手边！
SpO ₂ 骤降	排查氧瓶耗尽/管路扭结/气胸	立即查氧源→备用手摇→评估是否终止转运回 ICU
MAP 骤降	提高 ECMO 流量/补液(备用 NS)/上调血管活性药	
氧气瓶耗尽	立即更换备用氧瓶（需预接好）	备用氧瓶须提前接好置转运床上
2.6 到达目标科室后		
操作	执行	
接回墙式电源（拔电池）、墙式氧源/空气源	□	
重新连接变温水箱（如之前断开）	□	
重新确认 ECMO 参数（流量/RPM/扫气/FiO ₂ ）无变化	□	
重新确认插管深度无变化	□	
重新确认呼吸机/监护仪参数	□	
测 ACT+血气（转运后首次）	□	
与目标科室医护人员完整交班	□	

依据：ELSO 转运指南+ELSO Specialist Training Manual(第 4 版)+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）；

用途：ECMO 患者的院内转运（CT/导管室/手术室）及院际转运标准化流程；

核心原则：转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。